

PATOLOGÍA DEGENERATIVA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Mostaza Antolín Laura, González Martínez Emilio, Alonso Claro Gonzalo

INTRODUCCIÓN

La patología degenerativa espinal es una condición frecuente e incapacitante en ocasiones. Ocurre como consecuencia de la edad. Aproximadamente el 85% de las personas con más de 60 años padecen algún grado de degeneración en los discos intervertebrales, aunque habitualmente esto es asintomático. Es la segunda causa de baja laboral, solo por detrás del resfriado común.

PATOLOGÍA CERVICO-DORSAL

La hernia discal se produce cuando el disco intervertebral sufre un desplazamiento más allá del límite posterior del cuerpo vertebral. El nivel más frecuentemente afectado es C6-C7 (69%), seguido por C5-C6 (19%), y C7-T1 (10%). La afectación dorsal es excepcional.

Clínica

- **Afectación mielo-radicular**
 - **Mielopatía:** compresión medular con signos clínicos de afectación de primera motoneurona. Ocasionalmente es debido a compresión por procesos de espondiloartrosis. La sintomatología principal es una paraparesia espástica en miembros inferiores, asimétrica, que comienza como una debilidad progresiva al andar.
 - **Radiculopatía:** es la clínica más frecuente en forma de dolor o parestesias en la distribución de la raíz con signos clínicos de afectación de segunda motoneurona. Puede asociar cervicalgia.
 - Mixta: afectación mieloradicular.
- **Cervicalgia:** principalmente por contractura muscular.

Exploración física

	Lesión de primera motoneurona	Síndrome de segunda motoneurona
Localización	Medular (o cortical)	Radicular
Tono muscular	Espasticidad	Flaccidez
Reflejos tendinosos	Hiperactivos con/sin clonus	Ausentes
Reflejos patológicos	Hoffman; Babinski	Ausentes
Manifestaciones musculares	Espasmos, atrofia por desuso	Fasciculaciones y fibrilaciones; atrofia por trastornos tróficos

Características diferenciales de lesión de primera y segunda motoneurona

- Palpación de espinosas y musculatura cervical, en búsqueda de puntos dolorosos.
- Movilidad activa y pasiva de la columna cervical (lateralización y flexo-extensión del cuello).
- Fuerza por grupos musculares: elevación del brazo (C5), flexión (C6) y extensión (C7) del codo y muñeca, y separación de los dedos (C8).
- Sensibilidad táctil: primer y segundo dedo (C6), tercer dedo (C7), y cuarto y quinto dedo (C8).
- Reflejos miotáticos: Bicipital (C5-C6), Estilorraxial (C6), Tríceps (C7). Exploración de intensidad, área reflexógena y presencia de clonus.
- Reflejo de Hoffman: tras el golpeteo en la falange distal del II dedo, se produce una contracción en flexión de los dedos de la mano, y de manera muy llamativa del pulgar (indicador de lesión de primera motoneurona).

- Pruebas de provocación:
 - Maniobra de Spurling: lateralización y compresión del raquis cervical con reproducción de dolor radicular.
 - Alivio frecuente con la elevación del brazo.
- En la mielopatía cervical podremos observar el reflejo de Hoffmann y el estilorrádial invertido en las extremidades superiores, y el reflejo de Babinski en las extremidades inferiores

Pruebas complementarias

- **Radiografía cervical:**
 - **Rectificación de curvatura fisiológica:** indicador de contractura cervical.
 - **Subluxación vertebral.**
 - **Osteofitos vertebrales:** indicador de cervicoartrosis; poco específico.
- **TC/RM cervical:** rara vez se realiza de Urgencias. El TC cervical aporta escasa información de las partes blandas (ligamentos y disco intervertebral).

PATOLOGÍA LUMBAR

Hernia discal lumbar

Salida de material discal de los límites anatómicos del disco intervertebral. El segmento más frecuentemente afectado es el L5-S1 (45%), seguido por L4-L5 (40%).

Clínica

- **Lumbalgia:** principalmente de características mecánicas. Es frecuente que asocie contractura muscular.
- **Radiculopatía:** dolor irradiado por territorio radicular (ciática). Ocasionalmente puede presentarse en forma de déficit motor agudo de la raíz L5 (con o sin dolor asociado), denominado en el argot médico “pie caído”.
- **Síndrome de cauda equina:** Si el fragmento es grande o la hernia es alta puede comprimirse toda la cola de caballo. Los síntomas incluyen debilidad y entumecimiento en ambas piernas, dolor rectal, entumecimiento perineal, y parálisis de los esfínteres. Siempre que se sospeche este diagnóstico la evaluación y el tratamiento deberán ser agresivos.

Estenosis de canal

Es la compresión de los elementos neurales vertebrales a nivel del canal vertebral o del agujero de conjunción. Principalmente debido a la hipertrofia de las carillas articulares o del ligamento amarillo.

Clínica

- **Radiculopatía.**
- **Claudicación neurógena de la marcha:** clínica progresiva de dolor radicular o molestias en las piernas asociada a dolor en nalgas, ingles y cara anterior del muslo. El dolor habitualmente es simétrico, pero puede manifestarse unilateralmente; se desencadena con la deambulación, obligando al paciente a descansar hasta poder reemprender la marcha.

	NEUROGÉNICA	VASCULAR
Mecanismo	Mecánico y/o Isquémico	Isquémico
Distribución del dolor	Radicular (dermatoma)	Grupo muscular (esclerotoma)
Distribución del trastorno sensitivo	Radicular (dermatomal)	“En calcetín”
Distancia de claudicación	Variable “día a día”	Constante

	NEUROGÉNICA	VASCULAR
Mejoría	Reposo	Reposo
	Lenta y variable Dependiente de postura -Sedestación- Flexión lumbar	Rápida Independiente de la postura
Empeoramiento	Bajar cuesta (por hiperlordosis)	Subir cuesta (por aumento de exigencias)
Síntomas y signos asociados	Dolor lumbar Vejiga neurógena Déficit motor	Trastornos tróficos
Pulsos periféricos	Conservados	Ausentes

Características diferencias de la claudicación neurogénica y vascular.

Exploración Física En La Patología Lumbar Degenerativa:

- Inspección: marcha y prueba talón-puntillas.
- Fuerza: explorada por grupos musculares: flexión de cadera (raíz L2 y L3), extensión de rodilla (L4), flexión dorsal del dedo gordo del pie (L5), y flexión plantar del dodo gordo del pie (S1).
- Sensibilidad táctil: muslo (raíz L2, L3 y L4), cara anterior de la pierna (L5), y cara posterior de la pierna (S1).
- Maniobra de Lasègue: con el paciente decúbito supino, se realiza extensión pasiva de la pierna con la rodilla extendida. Positiva en radiculopatía L5 y S1, y en menor medida L4. Cuando la maniobra reproduce un dolor radicular en la pierna contralateral a la explorada se denomina Lasègue cruzado, que es habitual en hernias posterocentrales.
- Maniobra de Lasègue invertido: con el paciente en decúbito prono, se realiza una extensión pasiva del psoas con la rodilla flexionada. Positiva cuando reproduce el dolor, y es indicador de afectación radicular alta (L2 o L3).

Pruebas Complementarias En La Patología Lumbar Degenerativa

- **Radiografía lumbar**
 - **Rectificación de curvatura fisiológica:** indicador de contractura cervical.
 - **Espondilolistesis vertebral** (subluxación vertebral).
 - **Espondilolisis:** fractura del istmo vertebral (característica imagen del “perrito escocés” decapitado).
 - **Osteofitos vertebrales:** indicador de lumboartrosis; poco específico.
- **TC/RM cervical:** rara vez se realiza de Urgencias. El TC lumbar aporta escasa información de las partes blandas (ligamentos y disco intervertebral).
 - **RM lumbar** urgente si sospecha de síndrome de cauda equina o déficit motor agudo (constituye una urgencia quirúrgica).

Actitud Terapéutica En Urgencias En La Patología Degenerativa

- Tratamiento médico:
 - Analgésicos y anti-inflamatorios.
 - Relajantes musculares (p.ej. Diazepam).
 - Gabapentina/Pregabalina si dolor neuropático (iniciar a dosis progresivas).
- Recomendaciones higienico dietéticas:
 - Reposo relativo.
 - Evitar faja lumbar o collarín: debilita la musculatura paravertebral.

- Calor local.
- Valoración por Especialista en Raquis si:
 - Clínica de radiculopatía con dolor intratable, déficit motor o sensitivo.

Cumple criterios de bandera roja.

Posible neoplasia o infección	Posible fractura o compresión	Posible síndrome de cauda equina
Edad > 50 o < 20 años Antecedente oncológico Pérdida de peso inexplicable Factores de riesgo de infección espinal (infección bacteriana reciente, ADVP, cirugía reciente de columna) Inmunosupresión Dolor nocturno severo que empeora con el decúbito	Traumatismo menor o esfuerzo de levantamiento en paciente añoso y con osteoporosis. Traumatismo mayor. Tratamiento corticoideos.	Anestesia en silla de montar. Afectación vesical (retención urinaria, polaquiuria e incontinencia por hiperaflujo). Déficit motor en miembros inferiores.

Tabla 3. Banderas rojas del dolor lumbar.

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral.